

Lupus eritematoso sistémico

Normas H. Elizalde 2012

Enfermedad autoinmune multisistémica con manifestaciones clínicas, curso y pronóstico muy variable. Se caracteriza por la alternancia de períodos de recaídas y remisiones, y pueden estar involucrados diversos órganos y sistemas en forma aislada o en combinación.

Etiopatogenia

Excepto el lupus inducido por drogas, la etiología del LES es desconocida. Es una enfermedad multifactorial en la que actúan factores ambientales como luz ultravioleta, estrés emocional y agentes infecciosos, que al afectar a un huésped genéticamente y hormonalmente predispuesto alteran el sistema inmune. Implica desórdenes en el sistema inmune celular con actividad excesiva y escasamente controlada de los linfocitos T, con producción de citoquinas que estimulan la activación policlonal de los linfocitos B, formado complejos inmunes que se depositan a nivel tisular.

El LES inducido por drogas se asocia con anticonvulsivantes tipo hidantoínas, clorpromasina y etosuximida, hidralazina, isoniazida, procainamida, alfametildopa y minociclina.

Epidemiología

En Estados Unidos la incidencia se estima en 0,6 casos por 100000 habitantes en el grupo de menores de 15 años.

Puede presentarse en cualquier edad, pero por lo general la mayor frecuencia es entre los 10 y los 14 años. Las niñas son 4,5 veces más afectadas que los varones.

Formas clínicas

El inicio de la enfermedad puede ser agudo con compromiso multisistémico o en forma insidiosa monosistémica u oligosistémica. Son de presentación y gravedad variable y dependen del órgano blanco afectado

Los pacientes pueden presentar inicialmente síntomas como:

- Fiebre prolongada
- Astenia
- Adinamia
- Hiporexia
- Pérdida de peso
- Linfadenopatías y hepatoesplenomegalia

Criterios diagnóstico de la *American College of Rheumatology*

Par el diagnóstico de LES el paciente debe tener 4 o más criterios, pero no se requiere que estén presentes simultáneamente, pueden pasar meses o años antes de que el paciente cumpla cuatro criterios para su clasificación como LES.

- **Eritema malar en alas mariposa**

Eritema fijo, plano o sobreelevado, sobre las prominencias malares (respeta los pliegues nasolabiales)

- **Exantema discoide**

Placas eritematosas sobreelevadas con descamación queratósica adherente y condensación folicular; pueden dejar cicatriz atrófica.

- **Fotosensibilidad**

Exantema cutáneo como consecuencia de una reacción inhabitual a la luz solar

- **Úlceras orales**

Ulceración oral o nasofaríngea, generalmente, indolora

- **Artritis**

No erosiva que afecta a dos o más articulaciones periféricas

- **Serositis**

Pleuritis o pericarditis (otras no contenidas en los criterios: neumopatía intersticial, hemorragia pulmonar, tromboembolismo pulmonar e hipertensión pulmonar)

- **Compromiso renal**

Proteinuria persistente superior a 0,5 g/día o cilindros celulares (hemáticos, granulares, tubulares o mixtos)

- **Compromiso neurológico**

Convulsiones o psicosis en ausencia de fármacos causales o trastornos metabólicos. (otras: cefaleas, psicosis, trastornos emocionales, parálisis de nervios craneales o periféricos, síndrome de Guillain-Barré, meningitis aséptica, mielitis transversa, seudotumor, corea, ataxia, infarto cerebral o hemorragia intracraneal)

- **Trastorno hematológico**

Anemia hemolítica con reticulocitosis; leucopenia inferior a 4000 mm³ en dos o más ocasiones; linfopenia inferior a 1 500 mm³ en dos o más ocasiones; trombocitopenia inferior a 100000 mm³. Son también hallazgos frecuentes las alteraciones en la coagulación.

- **Trastorno inmunológico**

AntiADN positivo; antiSm; prueba serológica falsamente positiva para sífilis

- **Anticuerpos antinucleares**

Anticuerpos antinucleares FAN positivos

En más del 50 % de los pacientes pediátricos se detectan anticuerpos antifosfolípidos

Alteraciones digestivas no incluidas en los criterios: hepatomegalia, alteración de la función hepática, peritonitis aséptica, vasculitis con perforación o hemorragia, enteropatía con pérdida de proteínas, pancreatitis.

Anamnesis

- Antecedentes familiares de enfermedades autoinmunes y personales.
- Historia de psoriasis, infecciones, medicación o vacunaciones previas.
- Síntomas: inicio, cronología y duración.
- Antecedentes de fiebre, pérdida de peso, fotosensibilidad, caída de cabello, cambio de coloración en extremidades, úlceras orales, artralgias, artritis, dolor torácico, disnea, disfagia, cefaleas, convulsiones.

Examen físico

Dado el compromiso sistémico de la enfermedad es imprescindible realizar un examen físico completo que incluya:

- Peso, talla, tensión arterial, control de diuresis, edemas, presencia de derrames.
- Estado nutricional, lesiones en piel, mucosas y faneras.
- Examen neurológico, linfoganglionar, cardiovascular, respiratorio, abdominal (búsqueda de visceromegalias), articular y fuerza muscular.

Exámenes complementarios

- Hemograma con plaquetas y reticulocitos

PCR

PCD, ERS

Glucemia

Uremia, creatininemia

Colesterol total, TG, HDL, LDL

Hepatograma

Coagulograma

Proteinograma electroforético

Anticoagulante lúpico

Calcio, fósforo y magnesio

VD-RL

Serologías para hepatitis B, C y VIH

TSH, T4 libre, ATPO , ATG

FR, C3, C4, FAN, antiADN, anticuerpo al antígeno nuclear Smith (antiSm), AntiRNP, Ro, La.

Telerradiografía de tórax

PPD

Evaluación cardiológica: electrocardiograma y eco cardiograma.

Orina completa: pH , densidad, sedimento, microalbuminuria

Proteinuria de 24 horas, aclaramiento de creatinina.

Ecografía y biopsia renal.

Evaluación oftalmológica con fondo de ojo, agudeza visual, control de la presión intraocular, lámpara de hendidura y campimetria.

Compromiso neurológico: TAC cerebral RNM, angiografía.

Ante la sospecha de síndrome antifosfolípido: Ig A, Ig M e Ig G para anticardiolipinas y glicoproteínas.

- Ante sospecha de trombosis periférica realizar ecoDoppler de vasos profundos

Diagnóstico diferencial

Síndrome febril prolongado, artritis idiopática juvenil, miopatía, trastornos hematológicos (síndrome de Evans), enfermedades infecciosas, patología oncohematológica (leucemia), lesiones dérmicas de tipo vasculitis o fotosensibilidad, afección neurológica de etiología no aclarada.

Criterios de internación

- Paciente con sospecha de LES de reciente inicio para evaluación y tratamiento, de acuerdo con la evaluación del especialista.
- Todo paciente con rebrote de su enfermedad que requiera tratamiento endovenoso
- Paciente que por la condición de su inmunosupresión presente fiebre y deba descartarse un proceso infeccioso concomitante.

Tratamiento

Requiere abordaje interdisciplinario: reumatólogo, dermatólogo y nefrólogo en la mayoría de los casos.

La terapia debe adecuarse individualmente a la actividad de la enfermedad y a la extensión y gravedad del compromiso orgánico.

Medidas generales

- Debe educarse a pacientes y familiares acerca de las características de la enfermedad, evolución y pronóstico.
- Es necesario evitar la exposición de los pacientes a la luz solar y a los rayos ultravioletas en general, e indicar protectores solares.
- Deben lograrse tiempos prudenciales de reposo vinculados a la actividad de la enfermedad.
- Se debe ajustar la dieta a la afectación del órgano vital que predomine y a la existencia de hipertensión arterial o hiperlipidemia.
- Inmunización: no se recomiendan vacunas de virus vivos atenuadas, vacunación antigripal.
- Tratamiento precoz de las infecciones.
- Los anticonceptivos orales están contraindicados.
- Educación sexual.
- Debe brindarse apoyo psicológico a pacientes y familiares.

Tratamiento farmacológico

Se recomienda, antes de iniciar el tratamiento inmunosupresor, realizar radiografías de tórax y PPD.

1. Antiinflamatorios no esteroideos

Fiebre, artralgias, artritis y pleuropericarditis se pueden controlar adecuadamente con AINE.

2. Antimaláricos

Tienen acción antiinflamatoria, inmunomoduladora y protectora de la piel. Son útiles en el tratamiento de las manifestaciones cutáneas y artritis. La hidroxicloroquina es la mejor tolerada.

Efectos secundarios: toxicidad retiniana, dificultad para la acomodación, síntomas gastrointestinales, miopatía, pigmentación de la piel y neuropatía periférica.

Es necesario un control oftalmológico que incluya fondo de ojo, medición de la agudeza visual, examen con lámpara de hendidura y campimetría al inicio y luego con intervalos de seis meses.

3. Corticoides

Se pueden aplicar por vía tópica para el control de las manifestaciones cutáneas. En dosis bajas (prednisona o equivalentes, 0,5 mg/kg/día) se utilizan para el tratamiento de citopenias leves, pleuropericarditis y artritis que no responden al tratamiento con AINE.

Las dosis altas de esteroides (prednisona o equivalente, 1 mg/kg/día) se utilizan para el tratamiento de citopenias, pleuropericarditis, glomerulonefritis y otros compromisos viscerales graves. Se recomienda una dosis única diaria matinal.

En caso de no presentar respuesta clínica adecuada, el paciente puede requerir corticoides endovenosos o adicionarse inmunosupresores. Una vez alcanzado el efecto beneficioso se inicia la reducción progresiva.

Los pulsos de metilprednisolona (30 mg/kg EV durante tres días consecutivos o alternos) se utilizan en situaciones con compromiso grave renal, neurológico, pulmonar o multisistémico o que no responda a dosis altas de esteroides por vía oral.

4. Inmunosupresores

Los más utilizados en el tratamiento del LES son la ciclofosfamida vía oral o endovenosa, azatioprina, micofenolato mofecilo o metotrexate.

Pronóstico y seguimiento

A pesar de que el pronóstico del LES pediátrico ha mejorado de forma considerable durante los últimos años, sigue siendo una enfermedad que plantea grandes desafíos, sobre todo en casos de respuesta parcial al tratamiento, en los que el riesgo de complicaciones graves es elevado.

Las secuelas y la morbilidad del LES se asocian con varios factores de riesgo: la presentación en edades tempranas, el sexo masculino, el órgano o sistema afectado y las drogas utilizadas por largos períodos.

La supervivencia de los pacientes con nefropatía lúpica ha mejorado notablemente con la utilización de nuevas drogas inmunosupresoras.

La principal causa de muerte en la actualidad son las infecciones, más que la insuficiencia renal como ocurría anteriormente.

En cada visita, el reumatólogo infantil debe hacer una determinación del grado de afectación orgánica y del estado de actividad de la enfermedad.

La frecuencia de los controles durante el seguimiento se determinará individualmente y según la gravedad.

Por lo general, cuando el paciente está activo, se realiza mensualmente controles clínicos, exámenes complementarios y evaluaciones de acuerdo con el compromiso orgánico para detectar toxicidad medicamentosa.

En períodos de remisión, los controles se realizan cada tres meses, por lo menos, hasta que pasen dos años en inactividad donde podrán evaluarse cada seis meses.